

Navn:	Hallie Sofie Christoffersen
Fødselsdato:	271206
Skole:	Næstved Gymnasium og HF
Fag:	Studieretningsprojekt, Samlet vurd. (6647--Gym bekend,)
Dato for prøveaflægning:	24-03-2026

Studieretningsprojektet i 3.g 2026 – Opgaveformulering

Elev id: 3f13
Elev: Hallie Sofie Christoffersen

Fag	Vejleder
Psykologi C	Sisse Sahl Ibsen Email: ib@ngh.nu
Engelsk A	Dorte Jensen Email: do@ngh.nu

Område og opgaveformulering:**Hvordan behandles psykisk syge kriminelle i USA og Canada?**

Lav med udgangspunkt i nedenfor nævnte dokumentarudsendelser en psykologifaglig redegørelse for to udvalgte psykiske sygdomme og behandlingsmuligheder. Undersøg i hvilken grad disse to psykiske sygdomme er udbredt i fængsler i USA.

Analyser dokumentarfilmene *Out of Mind*, *Out of Sight* (2014) af John Kastner¹ og *The New Asylums* (2005) produceret af Miri Navasky og Helen O'Connor for PBS Frontline med fokus på årsagerne til fængselsdommen og fremstillingen af forholdene og behandlingen for de psykisk syge/indsatte i fængslerne. Kom herunder ind på forskelle og ligheder mellem USA og Canada. Analyser desuden hvordan de filmiske virkemidler understøtter fremstillingen af forholdene.

Diskuter med udgangspunkt i ovenstående samt bilag 1: "Jail Is Not Mental Health Care" i hvilken grad behandlingen af indsatte med psykisk sygdom i USA og Canada er hensigtsmæssig. Diskuter desuden hvilke følgevirkninger disse behandlinger kan have for patienterne og samfundet som helhed. Inddrag yderligere materiale.

Bilag 1 "Jail Is Not Mental Health Care"

https://bailproject.org/wp-content/uploads/2025/09/Mental_Health_Explainer_Double_Column-1.pdf

– en kampagnefolder fra The Bail Project, baseret på deres 2025 - rapport.

<https://bailproject.org/reports/jail-is-not-mental-health-care/> (besøgt 9/3 2026)



Billede 1: Shutterstock

Navn og klasse: Hallie Sofie Christoffersen 3f

Vejleder: Sisse Sahl Ibsen & Dorte Jensen

Afleveringsfrist: 24.03.2026 kl. 15:30

Resume

Denne opgave undersøger, hvordan psykisk syge mennesker behandles i retssystemet i USA og Canada, og i hvilken grad denne behandling er hensigtsmæssig. Formålet er at skabe en forståelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet samt vurdere, hvordan forskellige måder at håndtere problemet på, påvirker både individet og samfundet. Opgaven tager udgangspunkt i problemstillingen om, hvorvidt psykisk sygdom bør behandles som et sundhedsproblem eller som kriminalitet. Til at besvare dette anvendes både redegørelse, analyse og diskussion. Først redegøres der for psykiske sygdomme som skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse samt deres symptomer og behandling. Herefter analyseres dokumentarerne *Out of Mind*, *Out of Sight* og *The New Asylums* med fokus på forskelle og ligheder mellem USA og Canada, herunder årsager til kriminalitet, forholdene i institutionerne og behandlingen af de psykisk syge. Der inddrages også filmiske virkemidler for at belyse, hvordan de to systemer fremstilles. Som afslutning diskuteres det, om behandling er en bedre løsning end fængsling, og om fængsler fungerer som en erstatning for psykiatrisk behandling. Resultaterne viser, at psykisk sygdom kan have stor betydning for kriminalitet, især hvis sygdommen ikke behandles i tide. Det fremgår at Canada i højere grad har fokus på behandling og rehabilitering, mens USA i højere grad anvender fængsling samt kontrol. Opgaven konkluderer, at en behandlingsorienteret tilgang generelt er mere hensigtsmæssig, da den i højere grad løser de grundlæggende problemer og kan mindske risikoen for tilbagefald.

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Redegørelse	2
<i>Skizofrenidiagnosen.....</i>	<i>2</i>
<i>Behandling af skizofrenidiagnosen.....</i>	<i>3</i>
<i>Bipolar affekt sindslidelse</i>	<i>4</i>
<i>Behandling af bipolar affekt sindslidelse</i>	<i>5</i>
<i>Udbredelse af skizofreni og bipolar lidelse i fængsler i USA.....</i>	<i>5</i>
Analyse	6
Diskussion	12
<i>Fængsler som erstatning for behandling.....</i>	<i>13</i>
<i>Følgenvirkninger for patienterne</i>	<i>14</i>
<i>Følgenvirkninger for samfundet.....</i>	<i>15</i>
<i>Vurdering af behandlingen</i>	<i>15</i>
Konklusion	16

Indledning

Hvordan samfundet håndterer psykisk syge mennesker, der begår kriminalitet, er et vigtigt og aktuelt spørgsmål. I USA ser man, at mange psykisk syge ender i fængsler i stedet for at få behandling, mens der i Canada i højere grad er fokus på behandling frem for straf. Denne forskel gør det relevant at undersøge, hvilke konsekvenser det har og hvilken tilgang der er mest hensigtsmæssig. Fokus er derfor på sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet samt forskelle af håndteringen i USA og Canada.

Formålet er at undersøge, hvordan psykisk syge behandles i retssystemet i USA og Canada, og i hvilken grad denne behandling er hensigtsmæssig. For at besvare dette redegøres der først for sygdomme som skizofreni og bipolar lidelse samt deres behandling for at skabe en grundlæggende forståelse. Derefter analyseres dokumentarerne *Out of Mind, Out of Sight* (2014) af John Kastner og *The New Asylums* (2005) produceret af Miri Navasky og Helen O'Connor for PBS Frontline med fokus på forskelle og ligheder mellem de to systemer, forholdene i institutionerne og behandlingen af de psykisk syge. Der inddrages også filmiske virkemidler for at vise, hvordan de to systemer bliver fremstillet. Til sidst diskuteres det om behandling er en bedre løsning end fængsling og om fængsler fungerer som en erstatning for psykiatrisk behandling.

Redegørelse

I de senere år er der kommet større fokus på psykisk sygdom i retssystemet, især i USA, hvor mange psykisk syge personer ender i fængsler i stedet for at få behandling. Det rejser spørgsmål om, hvordan samfundet håndterer mennesker, der både er syge og har begået kriminalitet. Dokumentarerne *Out of Mind, Out of Sight* (2014) af John Kastner og *The New Asylums* (2005) produceret af Miri Navasky og Helen O'Connor for PBS Frontline giver et indblik i, hvordan psykisk syge bliver behandlet i henholdsvis Canada og USA. De viser to forskellige systemer og måder at håndtere problematikken på. For at kunne forstå problemstillingen er det nødvendigt først at se nærmere på, hvad psykiske sygdomme som skizofreni og bipolar lidelse er, hvordan de udvikler sig, og hvordan de behandles. Samtidig er det vigtigt at forstå, hvorfor så mange psykisk syge i især USA ender i fængsler.

Skizofrenidiagnosen

Skizofreni er en alvorlig psykisk lidelse, som påvirker en persons tanker, følelser og opfattelse af virkeligheden. Personer med skizofreni kan derfor have svært ved at skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er. Sygdommen begynder ofte i slutningen af teenageårene eller i starten af voksenlivet, hvor de første symptomer gradvist begynder at vise sig. Et af de mest kendte symptomer på skizofreni er psykoser. Psykoserne kaldes også de positive symptomer. Det kan blandt andet vise sig som vrangforestillinger, hvor personen tror på noget, der ikke er virkeligt. For eksempel kan en person være overbevist om, at andre forsøger at skade dem, eller at de bliver overvåget. Et andet typisk positivt symptom er hallucinationer, hvor personen oplever sanselige indtryk, selvom der i virkeligheden ikke er noget til stede. Det kan for eksempel være at høre stemmer, som taler til en eller giver en ordre. Derudover, findes der også det, man kalder negative symptomer. Negative symptomer handler ikke om, at man oplever noget, som ikke finder sted, men i stedet om at nogle af de normale funktioner bliver svagere. Personer med skizofreni kan have svært ved at føle glæde, vise følelser eller finde motivation til at gøre ting i hverdagen, hvilket kan gøre det svært at fungere i sociale relationer og daglige aktiviteter.¹

Årsagerne til skizofreni er ikke helt enkle. Forskning viser, at sygdommen ofte opstår på grund af en kombination af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Det betyder også, at risikoen for at udvikle sygdommen kan være større, hvis man har familiemedlemmer, der selv har skizofreni.² Samtidig

¹ Torben Østergaard Christensen & Gertrud Krarup, *Skizofreni – forståelse og behandling*, FADL's Forlag, 2011, s. 39.

² Torben Østergaard Christensen & Gertrud Krarup, *Skizofreni – forståelse og behandling*, FADL's Forlag, 2011, s. 48-49.

kan faktorer som stress, angst eller misbrug også spille en rolle i udviklingen af sygdommen.³ En skizofrenisygdom forløber sig i forskellige faser: første fase er den præmorbid fase, som forekommer helt fra fødslen af og indtil de første psykiske symptomer, som ofte starter i puberteten. Prodromalfasen er den fase, hvor symptomerne begynder at opstå. Dog er der ikke udviklet psykotiske symptomer endnu, de er blot blandede og uspecifikke. Først i selve sygdomsfasen starter psykosegennembruddet, altså når de første psykotiske symptomer optræder. Sygdomsfasen kan indledes i en akut fase, en stabiliseringsfase og en vedligeholdelsesfase.⁴ Den akutte fase indgår man i, ved første psykotiske gennembrud men den kan også opstå ved tilbagefald i sygdommen. Varigheden af den akutte fase afhænger af hvornår patienten kommer i behandling. Stabiliseringsfasen er selve fasen af sygdommen, hvor patienten begynder at genvinde sociale funktioner. I gennemsnit har stabiliseringsfasen en varighed på 1 år, hvilket ofte tager hårdt på både patienten og familierne. I Vedligeholdelsesfasen har patienten nået et plateau i sygdomsforløbet, hvor der er risiko for behandlingsdropout, altså at patienterne føler sig så raske, at de ikke mener behandlingen er nødvendig. Selvom patienterne føler sig raske sker der en fortsat langsom bedring i tilstanden hen over måneder og år og derfor er der vigtigt at patienten fortsat modtager behandling.⁵

Behandling af skizofrenidiagnosen

Selvom skizofreni er en alvorlig lidelse, findes der behandling, som kan hjælpe mange mennesker til at få et bedre liv. For de fleste personer i alderen 18-35 år med skizofreni tager behandlingen de første år udgangspunkt i OPUS-forløbet. Det er et forløb, som består af intensiv støtte i to år, der inkluderer medicin, social træning, inddragelse af pårørende og hjælp til at opretholde en normal dagligdag. Her får man tildelt en primærbehandler, som bliver patientens ”kontaktperson”, altså en person de har tiltro til, som der følger patienten igennem hele forløbet. De fleste personer med skizofreni får anti-psykotisk medicin, som dæmper primært de positive symptomer. Dog er det ikke altid, at det har en betydende virkning. De negative symptomer er sværere at behandle med medicin, da det typisk omhandler patientens følelser. Efter et OPUS-forløb går de fleste patienter videre til behandling via et F-ACT team (Flexible Assertive Community Treatment), som giver psykiatrisk behandling. Hvilket er behandling, hvor man ikke er indlagt, og man bliver set med længere mellemrum. Denne behandling består af en kombination af medicin, samtale, vejledning, samarbejde og støtte. En del af

³ Torben Østergaard Christensen & Gertrud Krarup, *Skizofreni – forståelse og behandling*, FADL's Forlag, 2011, s. 52.

⁴ Torben Østergaard Christensen & Gertrud Krarup: *Skizofreni forståelse og behandling*, 2011, s. 50-51.

⁵ Torben Østergaard Christensen & Gertrud Krarup: *Skizofreni forståelse og behandling*, 2011, s. 54.

behandlingen er i nogle tilfælde indlæggelse i psykiatrien. Det kan der for eksempel være behov for i begyndelsen for at finde stabilitet og for at sikre, at man får taget sin medicin ordentligt.⁶ I dokumentaren *Out of Mind, Out of Sight* (2014), instrueret af John Kastner, ser man f.eks. patienter på et psykiatrisk hospital i Canada, hvor behandlingen fokuserer på både medicin, terapi og rehabilitering. Her forsøger man at forstå patienternes sygdom og hjælpe dem til gradvist at blive mere stabile.⁷ Denne dokumentar bliver videreanalyseret senere i opgaven under analysen.

Bipolar affekt sindslidelse

Bipolar affekt sindslidelse er en psykisk sygdom, der påvirker en person ved, at der optræder episoder med både mani og depression eller gentagende manier. Denne sindslidelse begynder ofte tidligt i puberteten eller ungdomsårene. Det er vigtigt, at det bliver erkendt og behandlet tidligst muligt, da der er risiko for forværring med hyppige og svære episoder. Bipolar affektiv syge har desuden en høj selvmordsprocent på omkring 15%, hvilket gør det endnu vigtigere at sygdommen opdages og behandles i tide.⁸ Det gælder også om at få sygdommen under kontrol, da den hurtigt, og i stor grad, kan ødelægge den normale psykologiske og sociale udvikling.⁹ I en manisk episode kan personen føle sig ekstremt energisk, opstemt og irriteret. De kan have nedsat behov for søvn, øget sexlyst og nogle kan også blive impulsive og træffe risikable beslutninger, såsom at bruge mange penge eller handle aggressivt. Derimod er depressive episoder præget af tristhed, tab af evnen til at føle noget, nedsat appetit, nedsat evne til at koncentrere sig, øget behov for søvn og tab af evnen til at føle noget.¹⁰ Forløbet af en affektiv sindslidelse kan variere meget. Hos nogle personer ses flest episoder af manier med kun få depressionsepisoder, og hos andre dominerer de depressive episoder kun med enkelte lette mani anfald, som patienten ofte ikke selv registrerer. Nogle oplever også en blandingstilstand, hvor der både forekommer maniske og depressive symptomer. Varigheden af disse episoder er ofte fra få måneder op til et år, hvis der ikke gives behandling. Imellem de her episoder er man ofte helt rask og helt uden symptomer, dog oplever nogle personer at stemningslejet sjældent finder sin helt normale balance. Den bipolare affektive sindslidelse er ligesom ved skizofreni sandsynligvis en kombination af genetiske og biologiske faktorer, som optræder i hvert slægtled og derfor ofte ville være kendt fra andre familiemedlemmer, som også har haft lidelsen.¹¹

⁶ "Sådan foregår behandling af skizofreni", Bedre psykiatri

⁷ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 31:21 - 33:05.

⁸ Bertelsen, Aksel & Munk-Jørgensen, Povl: *De psykiatriske diagnoser*, 1998, s. 59.

⁹ Bertelsen, Aksel & Munk-Jørgensen, Povl: *De psykiatriske diagnoser*, 1998, s. 54.

¹⁰ Lars Vedel Kessing: *Mani og bipolar lidelse* - Sudhed.dk, 2023

¹¹ Bertelsen, Aksel & Munk-Jørgensen, Povl: *De psykiatriske diagnoser*, 1998, s. 54.

Behandling af bipolar affekt sindslidelse

Behandlingen af bipolar affekt sindslidelse har til formål at mindske symptomerne på sygdommen og samtidig forebygge nye sygdomsperioder, med andre ord altså at stabilisere stemningssvingningerne, så personer kan få en mere stabil hverdag. Behandlingerne tilpasses ofte den enkelte persons sygdomsforløb og de symptomer, der opleves i de forskellige faser. I de fleste tilfælde består behandlingen specielt af samtaleterapi, men medicin spiller også en central rolle i behandlingen, da den hjælper med at stabilisere humøret og forebygge både maniske og depressive episoder.¹² Den mest almindelige type medicin er stemningsstabiliserende medicin, som kunne være lithium eller antipsykotisk medicin, som også anvendes i behandlingen af skizofreni.¹³ Denne medicin bruges til at stabilisere hjernens signalstoffer og mindske risikoen for nye sygdomsperioder. Mange personer med bipolar lidelse anbefales derfor at tage medicin i længere tid, også selvom de i perioder føler sig stabile. Undervisning af sygdommen spiller også en vigtig rolle i behandlingen og kaldes psykoedukation, hvilket er en form for undervisning, hvor patienterne lærer mere om sin sygdom, dens symptomer og hvordan man kan forebygge tilbagefald.¹⁴

Udbredelse af skizofreni og bipolar lidelse i fængsler i USA

I dokumentaren *The New Asylums* (2005) produceret af Miri Navasky og Helen O'Connor for PBS Frontline bliver det tydeligt, at mange mennesker med psykiske sygdomme i USA ender i fængsler. Dokumentaren følger blandt andet et fængsel i Ohio, hvor en stor del af de indsatte lider af psykiske lidelser, såsom skizofreni og bipolar lidelse. En vigtig årsag til dette er, at mange psykiatriske hospitaler i USA blev lukket¹⁵. Tanken var, at patienter skulle behandles i lokalsamfundet i stedet for de psykiatriske hospitaler, men der er ikke oprettet nok behandlingsmuligheder, og derfor ender mange psykisk syge mennesker på gaden som hjemløse, hvor nogle begår mindre kriminalitet, som for eksempel tyveri, hvilket fører til at de havner i fængslet.¹⁶ Dokumentaren viser også, at psykisk sygdom er meget udbredt i det amerikanske fængselssystem. Omkring 500.000 psykisk syge personer sidder i fængsler i USA, hvilket er omkring ti gange flere end de ca. 50.000, der befinder sig på psykiatriske

¹² Behandling af bipolar lidelse - Sundhed Region Midtjylland.

¹³ Bertelsen, Aksel & Munk-Jørgensen, Povl: *De psykiatriske diagnoser*; 1998, s. 59.

¹⁴ Behandling af bipolar lidelse - Sundhed Region Midtjylland.

¹⁵ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 3:31 - 3:40.

¹⁶ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 4:02 - 4:20

hospitalet.¹⁷ Samtidig er omkring 16% af de indsatte i fængslet i Ohio diagnosticeret med en psykisk sygdom, hvilket viser at fængslerne fungerer som en slags erstatning for psykiatriske hospitalet.¹⁸ I fængslet bliver de indsatte med psykiske sygdomme ofte placeret i særlige afdelinger adskilt fra de andre fanger, hvor de får adgang til læger, psykologer og medicin. Alligevel viser dokumentaren at fængslerne ikke er egnede til behandling af psykiske syge. Hvis en indsat får et psykisk sammenbrud eller begynder at skade sig selv, kan fængslets specialstyrker blive tilkaldt for at lægge personen i håndjern eller lænker, hvilket kraftigt tyder på kun at have en negativ indflydelse på de psykisk syge indsatte mentale helbred.¹⁹ Denne dokumentar bliver videreanalyseret senere i opgaven under analysen.

Analyse

Dokumentarfilmene *Out of Mind, Out of Sight* (2014) instrueret af John Kastner og *The New Asylums* (2005) produceret af Miri Navasky og Helen O'Connor for PBS Frontline behandler begge problematikken omkring psykisk syge mennesker i retssystemet. Filmene sætter fokus på, hvordan personer med alvorlige psykiske lidelser kan ende i institutioner efter at have begået kriminalitet, men de fremstiller samtidig to meget forskellige systemer og tilgange til problematikken.

I den canadiske dokumentar følger man patienter på den retspsykiatriske afdeling på Brockville Mental Health Centre over en længere periode, hvor fokus er på behandling og rehabilitering. I den amerikanske dokumentar følger man derimod psykisk syge indsatte i et almindeligt fængselssystem i staten Ohio, hvor fokus i højere grad er på kontrol og sikkerhed. Ved at analysere og sammenligne de to dokumentarer bliver det tydeligt, hvordan forskelle i samfundets struktur og prioriteringer har stor betydning for både årsagerne til kriminalitet, forholdene i institutionerne og behandlingen af de psykisk syge.

I dokumentaren *Out of Mind, Out of Sight* bliver kriminalitet ofte forklaret som en direkte konsekvens af psykisk sygdom. De personer, man følger, er alle vurderet til at være utilregnelige, hvilket i Canada kaldes NCR (Not Criminally Responsible). Det vil sige, at de godt nok har begået en kriminel handling, men ikke kan holdes ansvarlige, fordi deres sygdom har påvirket deres evne til at forstå og

¹⁷ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 4:54 - 5:06.

¹⁸ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 7:23 - 7:57.

¹⁹ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 17:36 - 18:29

kontrollere deres handlinger.²⁰ Dokumentaren viser, hvordan alvorlige psykiske lidelser kan udvikle sig over tid og i værste fald føre til voldelige handlinger, især hvis sygdommen ikke bliver opdaget eller behandlet i tide. Et tydeligt eksempel er Michael Stewart, som lider af skizofreni. Gennem interviews med både ham selv, hans familie og læger får man et klart billede af, hvordan han tidligere var en velfungerende ung mand med venner og et godt liv. Men i slutningen af teenageårene begyndte hans personlighed at ændre sig, og han begyndte at opleve hallucinationer og høre stemmer.²¹ Disse stemmer, også kaldet “command hallucinations”, kunne give ham direkte ordrer, som var svære at ignorere.²² I en psykose endte det med, at han dræbte sin mor efter en konflikt i hjemmet.²³ Drabet på hans mor bliver ikke vist som en planlagt eller ond handling, men som en tragisk konsekvens af en sygdom, der ikke var under kontrol.²⁴

Flere andre patienter har lignende oplevelser. Carole Seguin oplever for eksempel hallucinationer, hvor hun hører sin søsters stemme,²⁵ hvilket skræmmer hende og kan føre til både selvskade og voldelige episoder²⁶. Sal Beninato, som også lider af skizofreni, har tidligere været voldelig over for sin familie. I en episode blev hans mor slået bevidstløs og lå i koma i flere uger.²⁷ Disse eksempler viser, hvordan psykisk sygdom i nogle tilfælde kan føre til vold, men dokumentaren understreger også, at det ikke er alle med psykiske lidelser, der bliver voldelige. Pointen er snarere, at risikoen bliver større, hvis sygdommen ikke bliver behandlet.²⁸

I dokumentaren *The New Asylums* bliver årsagerne forklaret på en anden måde. Her handler det ikke kun om den enkelte persons sygdom, men også om samfundets ansvar. Dokumentaren viser, at mange psykiatriske hospitaler i USA er blevet lukket, og derfor er der mange psykisk syge, som ikke får den hjælp, de har brug for. Det betyder, at mange ender på gaden som hjemløse og senere kommer i konflikt med loven, ofte på grund af mindre forbrydelser som tyveri eller uro i samfundet.²⁹ I stedet for at få hjælp bliver de anholdt og sendt i fængsel, men på den måde bliver deres sygdom ikke behandlet, men i stedet en del af deres kriminalitet. Dokumentaren peger også på, at omkring en halv

²⁰ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 16:00 - 16:15

²¹ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 16:27 - 17:34.

²² Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 10:35 - 11:29.

²³ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 27:51 - 28:15.

²⁴ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 1:17:53 - 1:20:20.

²⁵ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 9:17 - 10:34.

²⁶ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 23:07 - 23:35.

²⁷ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 11:37 - 12:29.

²⁸ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 4:00 - 4:21.

²⁹ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 3:31 - 3:40.

million psykisk syge personer sidder i amerikanske fængsler, hvilket er 10 gange mere end dem, der befinder sig på psykiatriske hospitaler.³⁰ Det vises tydeligt, at fængsler i USA er blevet en slags erstatning for de institutioner, der tidligere tog sig af de psykisk syge.

Samlet set viser de to dokumentarer to forskellige forklaringer på, hvorfor psykisk syge ender i systemet. I Canada bliver kriminalitet ofte set som en konsekvens af sygdom, mens det i USA i højere grad hænger sammen med manglende behandling og et system, der ikke hjælper dem i tide.

Når man kigger på forholdene i institutionerne, bliver forskellene mellem de to systemer meget tydelige. I den canadiske dokumentar bliver Brockville Mental Health Centre vist som et sted, hvor der arbejdes målrettet med behandling og rehabilitering. Patienterne er opdelt i forskellige sikkerhedsniveauer, kaldet B4, B3, B2 og B1. Det fungerer som et system, hvor de gradvist kan få mere frihed, hvis de viser, at de kan samarbejde og opføre sig stabilt.³¹ Personalet holder øje med patienterne og registrerer deres adfærd, men der er også stort fokus på behandling gennem terapi, medicin og forskellige programmer. Et eksempel er programmet "Symptom Management", hvor patienterne lærer at håndtere deres hallucinationer og få en bedre forståelse af deres sygdom.³² Samtidig prøver personalet at skabe en nogenlunde normal hverdag med aktiviteter og små belønninger. Patienterne kan for eksempel tjene lommepenge ved at følge reglerne og deltage i aktiviteter,³³ og nogle får også mulighed for at komme ud sammen med personale og lave ting som at bowle eller træne.³⁴ Selvom stedet stadig er lukket og kontrolleret, bliver patienterne set som mennesker, der har brug for hjælp og behandling.

I *The New Asylums* er forholdene meget anderledes og mere præget af kontrol og sikkerhed. Psykisk syge indsatte sidder ofte i almindelige fængselsceller og bliver i mange tilfælde behandlet som almindelige kriminelle³⁵. Dokumentaren viser flere situationer, hvor indsatte får psykiske sammenbrud, og hvor fængselsbetjente må bruge fysisk magt. I én scene ser man for eksempel en indsat, der under et anfald banker sit hoved ind i væggen hvor personalet forsøger at få kontrol over ham ved at fastholde ham og flytte ham til en anden celle, mens han skrider og beder om hjælp. I andre tilfælde bliver indsatte lagt i håndjern eller lænker, hvis de vurderes som farlige.³⁶ Disse situationer kan blandt andet

³⁰ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 4:54 - 5:06.

³¹ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 5:53 - 6:10.

³² Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 8:34 - 9:16.

³³ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 21:37 - 22:55.

³⁴ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 18:59 - 19:09.

³⁵ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 23:18 - 23:58.

³⁶ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 17:36 - 18:29.

forklares med *Philip Zimbardos Stanford Prison Experiment*, som viser hvordan mennesker hurtigt tilpasser sig de roller, de får i et fængselsmiljø. Eksperimentet viste, at personer i rollen som fængselsbetjente kan udvikle en mere kontrollerende og autoritær adfærd, mens “fangerne” bliver mere passive og psykisk påvirkede. Dette understøtter, at det ikke kun er den enkelte indsatte sygdom, der har betydning, men også selve miljøet og rollerne i fængslet, som kan forstærke konflikter og psykiske problemer.³⁷ De her kontrollerede situationer i dokumentaren giver derfor indtryk af et system, hvor fokus mest er på at holde orden og sikre kontrol, frem for at behandle de psykiske problemer. Selvom der også er psykologer og læger i fængslet, er der ikke nok ressourcer, og mange indsatte har aldrig fået behandling før. Nogle nægter også at tage medicin, fordi de tror, det ville gøre dem værre.³⁸

Der er tydelige forskelle på, hvordan USA og Canada håndterer psykisk syge mennesker, der begår kriminalitet. Noget af det vigtigste er, hvordan man overhovedet ser på psykisk sygdom. I Canada bliver psykisk sygdom mest set som et sundhedsproblem. Hvis en person begår noget kriminelt, men ikke har haft kontrol over sig selv på grund af sin sygdom, bliver personen ikke bare straffet. I stedet bliver de sendt til en psykiatrisk institution, hvor de kan få behandling. Her arbejder man med medicin og terapi, så de kan lære at håndtere deres sygdom bedre.³⁹ Tanken er, at hvis man hjælper dem, kan de få et bedre liv og måske komme tilbage til samfundet igen.⁴⁰

I USA er det anderledes. Her ender mange psykisk syge i almindelige fængsler, selvom deres problemer egentlig handler om sygdom. Systemet er først og fremmest lavet til at håndtere kriminalitet, ikke psykiske lidelser. En stor grund til det er, at mange psykiatriske hospitaler som sagt er blevet lukket. Derfor er der mange psykisk syge, som ikke får hjælp, og i stedet ender på gaden og senere i fængsel. På den måde kommer fængsler til at fungere som en slags erstatning for psykiatriske hospitaler.⁴¹

Der er også markant forskel på, hvordan hverdagen forløber sig. I Canada er der mere ro og struktur. Patienterne arbejder sig op gennem forskellige niveauer og kan få mere frihed, hvis de udvikler sig. De har aktiviteter og behandling, og der er en plan for, hvordan de kan få det bedre.⁴² I USA er det

³⁷ Schultz Larsen Ole, Psykologiens veje: “Zimbardo og virkelighedens fængsel”, Gl. Åby 2024, kapitel 24.

³⁸ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 9:26 - 10:00.

³⁹ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 43:30 - 44:05.

⁴⁰ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 1:24:37 - 1:26:35.

⁴¹ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 3:31 - 3:40.

⁴² Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 21:37 - 22:55.

en mere kaotisk hverdag, der kan være meget uro, og nogle får psykiske sammenbrud, hvor personalet må bruge magt. Det viser, at fængsler ikke rigtig er lavet til at hjælpe psykisk syge.

Behandlingen er også meget forskellig, i Canada er behandling nemlig en vigtig del af systemet, og man prøver aktivt at hjælpe patienterne. I USA findes der også behandling, men den er ofte begrænset, og mange får ikke den hjælp, de har brug for.

Selvom der er mange forskelle, er der også ligheder. Begge steder viser det sig, at psykisk sygdom ofte hænger sammen med kriminalitet, især hvis personen ikke har fået hjælp i tide. Begge systemer prøver også at finde en balance mellem at hjælpe og beskytte andre. I Canada er der stadig kontrol, fordi nogle patienter kan være farlige. I USA forsøger man også at give behandling, men det foregår inden for et fængsel, hvilket gør det sværere.⁴³

De filmiske virkemidler spiller en vigtig rolle i, hvordan forholdene for psykisk syge bliver fremstillet i de to dokumentarer. I *Out of Mind, Out of Sight* bliver der brugt virkemidler, som skaber ro og forståelse, mens *The New Asylums* i højere grad bruger virkemidler, der viser kaos og kontrol.

I den canadiske dokumentar er kameraet ofte roligt og stabilt, hvilket er med til at skabe en følelse af kontrol og struktur. Det ses blandt andet i minut 23:07 - 23:09 da en af patienterne ligger fastspændt i en seng (se bilag 1). Kameraet er centreret og bevæger sig ikke, hvilket gør, at situationen fremstår rolig, selvom den egentlig er alvorlig. Det gør, at man som seer ikke oplever det som voldsomt på samme måde, men mere som en del af behandlingen. På den måde understøtter virkemidlerne, at institutionen fremstilles som et sted med kontrol og behandling frem for kaos.

Et andet eksempel er en scene i minut 37:37 - 37:59, hvor patienter sidder udenfor på en bänk (se bilag 2). Her er kameraet i øjenhøjde og helt roligt, og der er ingen hurtige klip eller dramatisk musik. Det får situationen til at virke mere normal og hverdagsagtig. Det betyder, at man som seer ser patienterne som almindelige mennesker og ikke kun som kriminelle. De filmiske virkemidler er altså med til at understøtte et billede af et system, hvor der er plads til ro og menneskelighed.

I interviewet med Michael Stewart i minut 8:34–9:16 bruges der også nærbilleder (close-up), hvor kameraet går tæt på hans ansigt. Det gør, at man kommer tættere på hans tanker og oplevelser, især

⁴³ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 14:40 - 15:05.

når han forklarer sine hallucinationer. Samtidig er der ingen baggrundsmusik, hvilket gør scenen mere realistisk og troværdig.⁴⁴

Klipningen i den canadiske dokumentar er generelt langsom, og scenerne får lov til at vare. Det giver tid til refleksion og gør, at man som seer bedre kan forstå situationen. Samlet set understøtter de filmiske virkemidler, at forholdene fremstår strukturerede og behandlingsorienterede.

I *The New Asylums* er de filmiske virkemidler markant anderledes og understøtter et helt andet billede af forholdene. Et tydeligt eksempel er scenen i minut 6:06 - 6:23 med gruppeterapi, hvor de indsatte sidder i bure (se bilag 3). Selvom det kaldes terapi, sidder de indsatte isoleret i hver deres bur. Kameraet er filmet oppefra i fugleperspektiv, så man kan se hele rummet. Det gør, at de indsatte virker små og fangede, næsten som dyr i et bur. Det skaber en følelse af afstand og viser, at de ikke bliver behandlet som patienter, men som fanger. Samtidig er omgivelserne kolde og upersonlige, hvilket forstærker indtrykket af et hårdt miljø.

I en anden scene i minut 19:46 - 19:52 ser man indsatte, der står lænket sammen i en række (se bilag 4). Kameraet er i øjenhøjde, hvilket gør scenen mere direkte og realistisk. Kæderne er meget synlige og fungerer som et symbol på kontrol og manglende frihed. Hvilket understreger, at systemet har fokus på sikkerhed frem for behandling.

En af de mest intense scener er fra et klip i minut 17:36–18:38, hvor en mand får et psykisk sammenbrud. Her bruges håndholdt kamera, hvilket gør billedet rystet og uroligt. Det får det til at føles, som om man selv er til stede i situationen. Når specialstyrken kommer ind og lægger ham i håndjern, mens han skrider, bliver scenen endnu mere voldsom. De filmiske virkemidler gør, at man oplever situationen som kaotisk og stressende, og det understøtter, hvor hårdt systemet reagerer.⁴⁵ Lige efter dette voldsomme klip skifter filmen til et roligt interview i minut 18:40–18:56, hvor en af patienterne forklarer hans begrundelse for, hvorfor han sidder i fængslet. Det skaber en kontrast, der gør, at man får mere empati med den indsatte og forstår, at der er tale om et menneske med problemer ikke bare en kriminel.⁴⁶

⁴⁴ Kastner, John: *Out of Mind, Out of Sight*. Canada, 2014, tidskode 8:34 - 9:16.

⁴⁵ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 17:36 - 18:38.

⁴⁶ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 18:40 - 18:56.

Generelt bruger den amerikanske dokumentar hurtigere klip, mere uro i kameraet og mere intense scener. Det giver et billede af et system, der er presset og ikke har de nødvendige ressourcer til at håndtere psykisk syge. Derudover bruges der også fakta, for eksempel at omkring 500.000 psykisk syge sidder i amerikanske fængsler, dette kan ses i klippet 4:54–5:02. Det gør fremstillingen mere troværdig, og viser at problemet er stort.⁴⁷

Samlet set viser de to dokumentarer, at psykisk sygdom og kriminalitet hænger tæt sammen, men at måden samfundet håndterer det på, er afgørende for både årsager og konsekvenser. I Canada bliver psykisk sygdom primært behandlet som et sundhedsproblem, hvor fokus er på rehabilitering og at hjælpe den enkelte videre. I USA bliver mange psykisk syge derimod en del af et fængselssystem, som ikke er indrettet til at håndtere deres problemer, hvilket kan forværre deres situation. De filmiske virkemidler understøtter tydeligt disse forskelle. Den canadiske dokumentar bruger rolige billeder og langsom klipning, som skaber forståelse og empati, mens den amerikanske dokumentar bruger mere uroligt kamera og intense scener, der fremhæver kaos og kontrol. På den måde viser dokumentarerne ikke kun to forskellige systemer, men også to forskellige syn på psykisk sygdom, enten som noget der skal behandles, eller noget der i praksis bliver straffet.

Diskussion

I hvilken grad er behandlingen hensigtsmæssig?

Om behandlingen af psykisk syge indsatte i USA og Canada er hensigtsmæssig, afhænger i høj grad af, hvordan man ser på problemet. Overordnet virker behandling som en bedre løsning end fængsling, men det gælder ikke i alle situationer. Kilderne peger nemlig på forskellige ting, nogle fokuserer på manglende behandling i fængslerne, mens andre viser at problemerne allerede starter før folk overhovedet ender der. Derfor er der ikke én simpel løsning, og det kan diskuteres, om problemet i virkeligheden ligger i selve behandlingen eller i systemet omkring det.

Bilaget *Jail Is Not Mental Health Care* er meget kritisk over for den Amerikanske tilgang, og beskriver hvordan: *“people with acute psychiatric distress are arrested instead of helped, held in jail cells instead of treated”*.⁴⁸ Det viser ret tydeligt, at personer i psykisk krise ofte bliver mødt med straf

⁴⁷ Navasky, Miri & O'Connor, Helen: *The New Asylums*. PBS Frontline, USA, 2005, tidskode 4:54 - 5:02.

⁴⁸ The Bail Project: *“Jail is not mental health”*, 2025, s. 2, linje 4-6.

i stedet for hjælp. Samtidig tyder det på, at politiet i mange tilfælde bliver dem der håndterer situationer, som egentlig burde ligge hos sundhedssystemet. Den samme holdning går igen hos organisationen NAMI, men her er fokus mere på, hvad der sker inde i fængslerne. De skriver, at “63%... *do not receive mental health treatment while incarcerated in state and federal prisons*”.⁴⁹ Det betyder, at selv når personer er blevet en del af systemet, får de stadig ikke den behandling, de har brug for. Hvor bilaget *Jail Is Not Mental Health* især kritiserer starten af forløbet, viser organisationen NAMI, at problemerne fortsætter hele vejen igennem. Det understreger, at problemet ikke kun handler om adgang til systemet, men også om kvaliteten af den behandling patienterne tilbydes.

Den Canadiske rapport giver en lidt anden vinkel og peger på, at problemet ofte starter tidligere. Her står der, at manglende støtte kan føre til: “*a cycle of poverty, homelessness, criminality, and addictions*”.⁵⁰ Det peger på, at man ikke kun kan fokusere på fængslerne, men også må se på de sociale forhold, som kan føre til kriminalitet i første omgang. Det gør også diskussionen bredere, fordi løsningen ikke kun handler om behandling eller straf, men om hele samfundets indsats. Derfor virker behandling i høj grad som en bedre løsning end fængsling, fordi den går mere i dybden med problemerne. Men det er kun tilfældet, hvis behandlingen rent faktisk fungerer i praksis. Samtidig vil nogen mene, at fængsling stadig kan være nødvendig i visse situationer, for eksempel hvis en person der lider af psykiske sygdomme, er til fare for andre. Dette understreger, at løsningen i virkeligheden ofte ligger et sted midt imellem, hvor både behandling og kontrol kan spille en rolle.

Fængsler som erstatning for behandling

Et vigtigt spørgsmål er, om fængsler i praksis er blevet en slags erstatning for behandling. Bilaget *Jail Is Not Mental Health* beskriver fængsler som “*the country’s largest mental health institutions*”,⁵¹ hvilket er ret tydelig kritik. Det viser, at retssystemet i praksis håndterer problemer, som egentlig burde ligge i sundhedssystemet. Det kan ses som et tegn på, at der er sket en ændring i, hvem der har ansvaret for psykisk syge. Organisationens NAMI bakker op om denne holdning og viser, hvor mange psykisk syge der sidder i fængsler, og hvor få der får behandling: “*37% in state and federal prisons and 44% held in local jails*”.⁵² Hvor bilaget forklarer problemet mere overordnet, gør organisationen

⁴⁹ National Alliance on Mental Illness: “Mental Health Treatment While Incarcerated”, 2021, 22-24.

⁵⁰ Mental Health Commission of Canada: “Mental health and the criminal justice System: What We Heard”, 2017, s. 1, linje 4.

⁵¹ The Bail Project: “*Jail is not mental health*”, 2025, s. 2, linje 2-3.

⁵² National Alliance on Mental Illness: “Mental Health Treatment While Incarcerated”, 2021, s. 1, linje 11-12.

NAMI det konkret med tal, som viser hvor stort en del der modtager behandling.⁵³ Det gør det svært at argumentere for, at fængsler fungerer som en god løsning. Den canadiske rapport giver dog en lidt anden forklaring. Her bliver det tydeligt, at mange allerede er blevet svigtet, før de ender i fængsel.⁵⁴ Det betyder at fængsler ikke kun er problemet, de er også et resultat af, at systemet ikke har grebet ind hurtigt nok. Det kan derfor diskuteres, om fokus bør ligge på at ændre fængslerne, eller på at forbedre indsatsen tidligere i forløbet, så flere personer med psykiske lidelser kan hjælpes hurtigst muligt. Man kan derfor sige, at fængsler i høj grad fungerer som en erstatning for behandling, men også at det ikke er hele forklaringen på problemet. Nogen vil argumentere for, at fængsler i visse tilfælde kan give struktur og faste rammer, som de fleste psykiske syge har brug for. For eksempel kan personer uden bolig eller netværk opleve en form for stabilitet samt struktur i hverdagen, når de er kommet i fængsel.

Følgenvirkninger for patienterne

Når man ser på konsekvenserne for den enkelte, bliver forskellen mellem behandling og fængsling meget tydelig. Ifølge bilaget *Jail Is Not Mental Health* bliver indsatte: “*cut off from existing treatment, placed in isolation... and exposed to violence*”.⁵⁵ Det viser, at fængsling ikke bare mangler behandling, men faktisk kan gøre hele situationen værre. Det kan føre til, at symptomer bliver forstærket i stedet for reduceret. NAMI organisationen peger på det samme og viser, at 50% af de indsatte mister deres behandling og medicin under opholdet.⁵⁶ Det betyder, at personer, der måske havde det nogenlunde stabilt før, kan få det langt dårligere. Samtidig kan det være svært at genoptage behandling efter løsladelse, hvilket øger risikoen for tilbagefald. Den canadiske rapport viser også, at det kan forværre situationen at blive isoleret fra familie og netværk.⁵⁷ Samtidig kan selve fængslingen skabe nye psykiske problemer.⁵⁸ Det gør det tydeligt, at konsekvenserne ikke kun handler om manglende behandling, men også om selve miljøet. Omvendt kan behandling hjælpe personer med at få en mere stabil hverdag. Men det kræver, at hjælpen vil fortsætte hen over længere tid. Hvis hjælpen for eksempel stopper efter patienternes løsladelse, kan effekten hurtigt forsvinde igen. Derudover kan det

⁵³ National Alliance on Mental Illness: “Mental Health Treatment While Incarcerated”, 2021, s. 1, linje 22-24.

⁵⁴ Mental Health Commission of Canada: “Mental health and the criminal justice System: What We Heard”, 2017, s. 4, linje 15-16.

⁵⁵ The Bail Project: “*Jail is not mental health*”, 2025, s. 3, linje 14-16.

⁵⁶ National Alliance on Mental Illness: “Mental Health Treatment While Incarcerated”, 2021, s. 1, linje 27-30.

⁵⁷ Mental Health Commission of Canada: “Mental health and the criminal justice System: What We Heard”, 2017, s. 1, linje 12-13.

⁵⁸ Mental Health Commission of Canada: “Mental health and the criminal justice System: What We Heard”, 2017, s. 1, linje 15-16.

have stor betydning for ens fremtid, om man bliver set som kriminel eller som en person med en sygdom, da det påvirker mulighederne for at få job og skabe et stabilt liv efterfølgende.

Følgevirkninger for samfundet

Det handler ikke kun om den enkelte, det har også betydning for samfundet. Fængsling kan godt skabe tryghed på kort sigt, fordi farlige personer bliver fjernet fra gaden. Det kan være vigtigt i situationer, hvor der er risiko for vold eller skade. Men på længere sigt viser bilaget *Jail Is Not Mental Health*, at det kan føre til “*a cycle of incarceration, deterioration, and recidivism*”.⁵⁹ Det betyder, at personer ofte ender tilbage i systemet, fordi deres problemer ikke bliver løst eller helbredt. På den måde bliver fængsling en gentagende løsning, der ikke ændrer den på grundlæggende situation nemlig den psykiske lidelse. Samtidig viser bilaget, at behandling er billigere end fængsling. I Californien koster det over 70.000 dollars om året at fængsle en person, mens behandling kun koster omkring 22.000 dollars.⁶⁰ Dette tyder på, at behandling ikke kun er bedre for den enkelte, men også er en økonomisk fordel for samfundet. Selvom behandling i sidste ende er billigere, er det vigtigt at huske, at fængsling stadig kan være nødvendigt i nogle situationer, især hvis en person har farlig adfærd. Derfor er det ikke realistisk helt at fjerne fængsling, men det kan diskuteres, hvor stor en rolle, det bør spille i forhold til behandling.

Vurdering af behandlingen

Samlet set peger diskussionen på, at behandling i høj grad er den mest hensigtsmæssige løsning, fordi den går mere i dybden med problemerne, og kan forbedre både individets og samfundets situation. Dette understøttes blandt andet af, at personer i krise bliver “*arrested instead of helped*”. Samtidig viser både NAMI organisationen og den Canadiske rapport, at behandling kun virker, hvis den er tilgængelig og hænger sammen. Derfor er det ikke nok bare at sige, at behandling er bedre, det afhænger af hvordan den bliver udført i praksis. Den mest præcise vurdering er derfor, at behandling i høj grad er hensigtsmæssig, men ikke i alle tilfælde, og at fængsling i nogle situationer stadig kan være nødvendig.

⁵⁹ The Bail Project: “*Jail is not mental health*”, 2025, s. 2, linje 14-1.

⁶⁰ The Bail Project: “*Jail is not mental health*”, 2025, s. 6, linje 29-30

Konklusion

Formålet har været at undersøge, hvordan psykisk syge behandles i retssystemet i USA og Canada, samt i hvilken grad denne behandling er hensigtsmæssig. Opgaven viser, at psykisk sygdom og kriminalitet i nogle tilfælde hænger sammen, især hvis sygdommen ikke bliver opdaget eller behandlet i tide. Redegørelsen har vist, at sygdomme som skizofreni og bipolar lidelse kan påvirke menneskers tanker og handlinger, hvilket i nogle tilfælde kan føre til kriminalitet. Samtidig fremgår det, at behandling kan være med til at stabilisere patienterne og forbedre deres liv. Analysen af dokumentarerne viser tydelige forskelle mellem USA og Canada. I Canada bliver psykisk sygdom i højere grad behandlet som et sundhedsproblem, hvor fokus er på behandling og rehabilitering. I USA ender mange psykisk syge i fængsler, hvor der er mere fokus på kontrol end behandling. De filmiske virkemidler understøtter denne forskel ved at vise ro og struktur i Canada og mere uro og kaos i USA. Diskussionen viser, at behandling generelt er en mere hensigtsmæssig løsning end fængsling, fordi den tager fat i de grundlæggende problemer. Samtidig tyder det på, at fængsler i USA i høj grad fungerer som en erstatning for manglende psykiatrisk behandling. Dog kan fængsling i nogle tilfælde være nødvendig, hvis en person er til fare for andre. Samlet set viser opgaven, at måden samfundet håndterer psykisk sygdom på har stor betydning. Canada repræsenterer en tilgang med fokus på behandling, mens USA i højere grad anvender straf. På den baggrund kan det konkluderes, at en behandlingsorienteret tilgang i højere grad er hensigtsmæssig, da den både kan hjælpe den enkelte og mindske kriminalitet.

Litteraturliste

Behandling af bipolar lidelse. Sundhed.rm.dk. Lokaliseret d. 16.03.2026 på <https://www.sundhed.rm.dk/sundhedstilbud/psykiatri/psykiatriske-sygdomme-hos-voksne/bipolar-lidelse-hos-voksne/behandling-af-bipolar-lidelse/>

Bertelsen, A. & Munk-Jørgensen, P. (1998). *De psykiatriske diagnoser*. Psykiatrifonden.

Christensen, T. & Krarup, G. (2011). *Skizofreni – forståelse og behandling*. FADL's Forlag.

Kastner, J. (2014). *Out of Mind, Out of Sight*. [dokumentarfilm]. Canada.

Kessing, L., (2023, 29.11). Mani og bipolar lidelse. *Sundhed.dk*. Lokaliseret d. 16.03.2026 på <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/mani-og-bipolar-lidelse/mani-og-bipolar-lidelse/>

Larsen, O.S. (2024). *Psykologiens veje*, [iBog]. Gl. Åby, Danmark: Systime.

Mental Health Commission of Canada. (2020). Mental health and the criminal justice system: 'What we heard'. Ottawa, Canada. Lokaliseret d. 18.03.2026 på. https://mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/drupal/2020-08/mental_health_and_the_law_evidence_summary_report_eng.pdf

Mental Health Treatment While Incarcerated. (2021). National Alliance on Mental Illness. Lokaliseret d. 18.03.2026 på. <https://www.nami.org/advocacy-at-nami/policy-positions/improving-health/mental-health-treatment-while-incarcerated/>

Navasky, M. & O'Connor, H. (2005). *The New Asylums*. [dokumentarfilm]. USA: PBS Frontline.

Sådan foregår behandling af skizofreni. Bedrepsykiatri.dk. Lokaliseret d. 16.03.2026 på <https://bedrepsykiatri.dk/raad/behandling-skizofreni/>

The Bail Project (2025). Jail is not mental health.

Bilag

Billede 1: <https://www.doktorn.com/artikel/kombination-av-schizofreni-och-autism-inte-omojligt/>



Bilag 1: Kastner, J. (2014). *Out of Mind, Out of Sight*. [dokumentarfilm]. Canada.



Bilag 2: Kastner, J. (2014). *Out of Mind, Out of Sight*. [dokumentarfilm]. Canada.



Bilag 3: Navasky, M. & O'Connor, H. (2005). *The New Asylums*. [dokumentarfilm]. USA: PBS Frontline.



Bilag 4: Navasky, M. & O'Connor, H. (2005). *The New Asylums*. [dokumentarfilm]. USA: PBS Frontline.

